Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Oubli de traitement

Adulte, enfant · prise oubliée, décalée ou incertaine

15 IMMÉDIAT · convulsion > 5 min ou répétée, ne répond pas, respire mal, malaise ; insuline oubliée avec vomissements, somnolence, respiration rapide et IDE non joignable.

J'applique si

- Prise **oubliée, décalée ou incertaine** ; dose recrachée, vomie ou retrouvée au sol.

Je ne fais pas

- **Doubler la dose** ou rapprocher deux prises sans avis.
- Supposer que la prise a été faite parce que le pilulier est vide.
- Tracer une prise non vérifiée.
- Attendre le lendemain pour un médicament critique.

J'agis

TOUT DE SUITE

1. **Ne pas donner** la prise oubliée ni la suivante en double **avant l'avis de l'IDE**.
2. Mettre de côté la dose non prise (pilulier, blister), sans la jeter.
3. Vérifier auprès de l'équipe précédente : prise faite **sans être tracée** ?
4. Quel médicament, quelle dose, quelle heure prévue ? **Critique** (carte) ?
5. Signes depuis l'oubli : crise, tremblements, raideur, malaise ; **glycémie** (AS/AP) si insuline.
6. Prévenir l'**IDE** dès la découverte : elle décide (donner, décaler, sauter) avec le médecin ou le pharmacien.

APRÈS ACCORD DE L'IDE OU DU MÉDECIN

7. Donner la dose décidée **seulement sur consigne**, notée au dossier.

ENSUITE

8. Enfant : parents selon le PAI. Déclaration interne (« Qui signale quoi, à qui ? »).

Critiques

Avis rapide, nuit comprise

- anticoagulant
- antiépileptique
- insuline
- antiparkinsonien
- corticoïde

J'appelle l'IDE sans délai

- **Tout oubli** ou doute sur une prise, dès la découverte.
- Médicament **critique** : sans attendre la prise suivante (IDE ou médecin d'astreinte, DOTR).
- Glycémie < 0,70 ou > 3 g/L, pouls < 50 ou > 120/min, comportement inhabituel.
- **IDE injoignable** : médecin d'astreinte ; signe de gravité : **15**.

Je surveille et je trace

- Médicament, heure prévue, heure de découverte, décision prise et par qui.
- Signes liés au médicament oublié (crise, glycémie, tremblements, douleur) selon les consignes.
- Oublis répétés : le signaler (horaires, sorties, week-ends, pilulier).

À retenir : Face à un oubli ou à un doute, on ne double jamais la dose : l'IDE ou le médecin décide. Un médicament critique oublié n'attend pas le matin.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road — Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : HAS, Outils de sécurisation et d'auto-évaluation de l'administration des médicaments (2011) ; arrêté du 26/06/2026 (actes AS/AP/AES), art. 2 ; CASF L313-26 ; fiche socle DOTR « Qui signale quoi, à qui ? » (10/2026).

Réf. DOTR-AS-OUBLI | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature